

ALERGIAS



ROTINA CLÍNICA

Modelos de evolução

ANAMNESE: URTICÁRIA

- **HDA:**

PACIENTE RELATA QUADRO DE PRURIDO CUTÂNEO, ASSOCIADO A RASH EM TRONCO, BRAÇOS E ABDOME, DE INÍCIO HÁ X MINUTOS. REFERE/NEGA TER TIDO CONTATO COM SUBSTÂNCIA SABIDAMENTE ALERGÊNICA.

NEGA DISPNEIA, TOSSE, DOR TORÁCICA, DOR ABDOMINAL INTENSA OU PRÉ-SINCOPE. OU OUTRAS QUEIXAS.

RELATA EPISÓDIO SIMILAR OCORRIDO HÁ X MESES.

- **HPP:**

ALERGIAS:

COMORBIDADES:

TABAGISMO/ETILISMO:

- **MEDICAÇÕES EM USO DOMICILIAR:**



EF: URTICÁRIA

GERAL: BEG, NORMOCORADA, HIDRATADA, ACIANÓTICA, ANICTÉRICA E AFEBRIL.

NEURO: LOTE, GLASGOW 15, SEM DÉFICITS FOCAIS APARENTES, PUPILAS ISOCÓRICAS E FOTORREAGENTES, SEM SINAIS DE IRRITAÇÃO MENÍNGEA.

AR: MVF+, SEM RUÍDOS ADVENTÍCIOS, EUPNEICA EM AR AMBIENTE, SAT.O₂: %, SEM SINAIS DE DESCONFORTO RESPIRATÓRIO.

ACV: RCR, 2T, BNF, S/ SOPROS, FC: BPM, PA: MMHG, TEC < 3 SEGUNDOS.

ABD: ATÍPICO, RHA PRESENTES NOS 4Q, TIMPÂNICO, FLÁCIDO, INDOLOR À PALPAÇÃO SUPERFICIAL E PROFUNDA, NÃO PALPO MASSAS E/OU VISCEROMEGALIAS, SEM SINAIS DE IRRITAÇÃO PERITONEAL.

MMII: SEM EDEMAS, SEM EMPASTAMENTO DE PANTURRILHAS.



EF: URTICÁRIA

PELE: PRESENÇA DE LESÕES ERITEMATOSAS, PRURIGINOSAS E EM PLACAS EM REGIÃO DE (BRAÇO, ABDOME, TÓRAX, ETC), COM BORDAS ELEVADAS.

MUCOSA: EDEMA PROFUSO DE MUCOSA LABIAL SUPERIOR E INFERIOR.



HD E CONDOTA

- **HIPÓTESE DIAGNÓSTICA:**

URTICÁRIA (URTICA E ANGIOEDEMA)

- **CONDUTAS:**

- SINTOMÁTICOS POR VIA ORAL AGORA
- FORNEÇO RECEITA MÉDICA COM SINTOMÁTICOS DOMICILIARES
- FORNEÇO ATESTADO MÉDICO
- ORIENTO ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL
- ORIENTO SINAIS DE ALARME E, EM CASO DA PRESENÇA DESTES, PROCURAR ATENDIMENTO MÉDICO IMEDIATAMENTE



ANAMNESE: ANAFILAXIA

- **HDA:**

PACIENTE RELATA QUADRO DE PRURIDO CUTÂNEO, ASSOCIADO A RASH EM TRONCO, BRAÇOS E ABDOME, DE INÍCIO HÁ X MINUTOS. REFERE AINDA TER TIDO CONTATO COM SUBSTÂNCIA SABIDAMENTE ALERGÊNICA.

QUEIXA-SE DE DISPNEIA, TOSSE E DOR TORÁCICA. (SINAIS DE ALARME)

NEGA DOR ABDOMINAL INTENSA OU PRÉ-SINCOPE.

RELATA EPISÓDIO SIMILAR OCORRIDO HÁ X MESES, PORÉM DE MENOR INTENSIDADE.

- **HPP:**

ALERGIAS:

COMORBIDADES:

TABAGISMO/ETILISMO:

- **MEDICAÇÕES EM USO DOMICILIAR:**



ROTINA CLÍNICA

EF: ANAFILAXIA

GERAL: REG, NORMOCORADA, HIDRATADA, ACIANÓTICA, ANICTÉRICA E AFEBRIL.

NEURO: LOTE, GLASGOW 15, SEM DÉFICITS FOCAIS APARENTES, PUPILAS ISOCÓRICAS E FOTORREAGENTES, SEM SINAIS DE IRRITAÇÃO MENÍNGEA.

AR: MVF+, COM PRESENÇA DE SIBILOS, TAQUIPNEICA EM AR AMBIENTE, SAT.O₂: %, COM SINAIS DE DESCONFORTO RESPIRATÓRIO, FR: IRPM

ACV: RCR, 2T, BNF, S/ SOPROS, FC: BPM, PA: MMHG, TEC < 3 SEGUNDOS.

ABD: ATÍPICO, RHA PRESENTES NOS 4Q, TIMPÂNICO, FLÁCIDO, INDOLOR À PALPAÇÃO SUPERFICIAL E PROFUNDA, NÃO PALPO MASSAS E/OU VISCEROMEGALIAS, SEM SINAIS DE IRRITAÇÃO PERITONEAL.

MMII: SEM EDEMAS, SEM EMPASTAMENTO DE PANTURRILHAS.



EF: ANAFILAXIA

PELE: PRESENÇA DE LESÕES ERITEMATOSAS, PRURIGINOSAS E EM PLACAS EM REGIÃO DE (BRAÇO, ABDOME, TÓRAX, ETC), COM BORDAS ELEVADAS.

MUCOSA: EDEMA PROFUSO DE MUCOSA LABIAL SUPERIOR E INFERIOR.



HD E CONDOTA

- **HIPÓTESE DIAGNÓSTICA:**

ANAFILAXIA

- **CONDUTAS:**

- TRANSIRO PACIENTE PARA SALA DE EMERGÊNCIA
- PRESCREVO ADRENALINA 0,5 MG IM AGORA
- SINTOMÁTICOS EV AGORA, INCLUINDO SALBUTAMOL SPRAY E HIDROCORTISONA
- HIDRATAÇÃO EV AGORA
- MANTENHO PACIENTE EM OBSERVAÇÃO POR NO MÍNIMO 6 HORAS
- **APENAS EM CASO ALTA APÓS:**
- ORIENTO ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL
- ORIENTO SINAIS DE ALARME E, EM CASO DE PRESENÇA DESTES, PROCURAR ATENDIMENTO MÉDICO IMEDIATAMENTE



ROTINA CLÍNICA